한국심리학회지: 중독
Korean Journal of Addiction Psychology
2025, Vol. 10, No. 2, 1-16

OPEN ACCESS

MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료 프로그램의 효과

양 규 열† 신 현 욱‡
대구교도소 심리치료팀 이음심리상담센터

본 연구는 대구지방교정청 산하 D 교도소에 수용된 성폭력 이수명령 대상자 24명을 대상으로, MBCT 기반 통합 심리치료 프로그램의 효과를 검증하기 위해 수행하였다. 참여자는 프로그램을 제공받은 실험집단 12명과 처치를 받지 않은 통제집단 12명으로 구성되었으며, 두 집단의 변화를 비교하기 위해 사전·사후에 SOTEST와 K-MAAS를 실시하였다. 분석 결과, 실험집단은 SOTEST의 인지태도, 자기관리, 성적관심 요인에서 통계적으로 유의한 감소를 보였고, 치료적 요인에서는 유의한 향상이 나타났으나 대인관계 요인에서는 유의한 변화가 나타나지 않았다. 반면 통제집단은 동일한 기간 동안 모든 요인에서 통계적으로 유의한 변화가 관찰되지 않았다. 또한 실험집단에서만 K-MAAS 점수가 유의하게 향상되어, 프로그램 참여 이후 마음챙김 수준이 증가한 것으로 확인되었다. 이러한 결과는 MBCT 기반 통합 심리치료 프로그램이 교정환경에서 성폭력 사범의 재범 위험 요인과 관련된 심리적 변인의 개선에 기여할 수 있음을 시사한다. 다만 본 연구는 표본 수가 제한적이고 특정 교정시설에 국한되어 수행되었으므로, 향후 연구에서는 다양한 교정시설을 대상으로 한 반복 검증과 대규모 표본을 활용한 후속 연구가 필요하다.

주요어 : 성범죄, 성폭력 사범, MBCT, 프로그램 효과, 수형자

† 교신저자(Corresponding Author) : 양규열, 법무부 대구교도소 심리치료팀, (42902) 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로 204, Tel: 053-430-1677, E-mail: gyyang@naver.com
‡ 신현욱, 이음심리상담센터, 대구광역시 동구 안심로22길 3 안심제1종합사회복지관, Tel: 053-962-3831, E-mail: bhc4525@naver.com.

Copyright ©2025, The Korean Addiction Psychological Association
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

성범죄는 피해자에게 심리적·신체적으로 지속적인 부정적 영향을 미치며, 사회 전반으로 심각한 사회문제에 상당한 비용을 초래한다. 교정 통계 연보에 따르면 교정기관 수형자 중 약 15.4%가 성범죄자이며, 동종 재복역률이 15.3%에 달해(법무부 교정본부, 2024), 성폭력 문제를 한층 더 심각하게 만드는 주요 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 성범죄자들을 대상으로 한 효과적인 심리치료 프로그램의 개발과 평가가 중요한 사회적 과제로 부상하고 있다(박지선, 이수정, 2018).

기존 교정기관의 성폭력 심리치료 프로그램은 주로 인지행동치료(Cognitive Behavioral Therapy; CBT)나 해결중심치료(Solution-Focused Therapy) 등의 전통적 접근에 기반하고 있다(김민영, 이태헌, 윤정숙, 2020). 이들 프로그램이 어느 정도 성과를 보인 것은 사실이나, 개입 방식과 참여자 특성에 따라 그 결과에 편차가 나타났다. 특히 장기적인 재범 방지 효과는 미흡하다는 연구 결과도 보고되고 있다(김정내, 이종연, 2017). 이러한 한계를 극복하기 위해 최근 중독 및 임상 심리 분야에서는 단일 치료기법의 적용을 넘어, 마음챙김을 핵심 기제로 하되 동기강화 및 재발방지 전략을 결합한 통합적 개입의 효과성에 주목하고 있다. 성범죄자 치료 역시 단순한 충동 억제를 넘어, 자신의 범죄 유발 요인을 자각하고, 변화의 필요성을 내면화하며, 위험 상황에 대처하는 기술이 유기적으로 작동해야 한다. 따라서 본 연구는 성범죄자의 특성에 맞춰 MBCT 원리에 동기강화와 재발방지 요소를 구조적으로 결합한 MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료 프로그램을 구성하고, 그 효과를 검증하고자 한다.

최근 대두되는 대안인 마음챙김 기반 인지치료(Mindfulness-Based Cognitive Therapy; MBCT)는 현재 순간의 경험에 주의를 기울이되 판단을 배제하는 마음챙김 원리를 인지 치료에 접목한 프로그램이다. 이는 내담자의 부정적 사고방식을 교정하고 심리적 고통을 경감시키기 위해 고안되었다(Garland et al., 2017; 전미애, 김정모, 2011). 원래 우울증 재발 방지를 위해 개발된 MBCT는 불안, 중독, 스트레스 등 다양한 심리 문제에도 효과적으로 적용되고 있다(Baer, 2003).

MBCT는 특히 성범죄자의 주요 재범 위험 요인인 인지 왜곡, 정서조절의 문제, 충동성, 공감 결여 등을 심층적으로 다룰 수 있는 치료적 강점을 지닌다(Marshall et al., 2011). 첫째, 인지 왜곡의 탈중심화(Decentering)를 가능하게 한다. MBCT는 사고 내용을 '틀렸다'고 반박하기보다, 그것을 '하나의 생각'으로 관찰하도록 하여 인지적 유연성을 높인다(Teasdale et al., 2002). 이는 강간 통념(Rape Myths)이나 범죄 합리화 사고에 대한 저항감을 줄이고, 왜곡된 신념에서 벗어날 수 있게 돕는다(Ma & Teasdale, 2004).

둘째, 주요 목표는 충동성 감소와 정서조절 능력의 증진이다. 마음챙김은 분노, 불안, 성적 충동과 같은 내적 경험을 비판단적으로 자각하도록 돕는다(문선희, 홍창희, 2012). 이러한 자각은 정서에 따른 기계적인 반응을 차단하고, 충동과 행동 사이에 의식적 틈을 형성하는 핵심 기제로 작용한다(Dimeff & Linehan, 2008). 이는 성범죄자들의 즉각적 행동화를 억제하고 자기통제력을 향상한다(Brewer et al., 2011).

셋째, 공감 능력과 자기 이해를 향상하는 효과가 있다. 자신의 문제 행동을 판단 없이 바라보는 태도는 자신을 방어하려는 심리를 완화한다(서수균, 김교헌, 2011). 결과적으로

자신의 행동에 대한 책임 의식이 높아지고 치료에 더 잘 순응하게 된다(Segal et al., 2006; Ward & Beech, 2006). 이는 타인의 감정을 이해하고 피해자에 대한 공감 능력을 회복하는 기반이 된다.

이처럼 성범죄자의 높은 재범률은 단순한 처벌 강화만으로는 해결될 수 없으며, 인지 왜곡, 충동성, 공감 결여와 같은 핵심 심리적 위험 요인을 다루는 효과적인 치료적 개입을 요구한다(김민영 외 2020). 기존의 표준 치료인 CBT는 그 효과성에도 불구하고, 특히 정서적·충동적 요소를 다루는 데 한계를 보여왔다(이동훈, 최윤희, 2015). MBCT는 탈중심화와 비판단적 수용의 기제를 통해 이러한 핵심 위험 요인들을 직접 다루고, 기존 CBT를 보완할 수 있는 유망한 대안으로 부상하고 있다(문선희 외 2012).

Kingston, Olver와 Gobeil(2018)은 성범죄자를 대상으로 한 무선 통제실험 연구에서 MBCT가 자기 조절, 정서조절, 재범 위험성에 긍정적인 효과가 있었으며, 마음챙김 프로그램이 성범죄자의 성적 환상, 충동에 미치는 효과를 검증하였다(Brouillette-Alarie et al., 2016). 이는 MBCT가 재범 예방의 중요 요인을 다룰 수 있음을 시사한다. 성범죄자를 대상으로 한 MBCT 적용 선행연구들은 심리 치료적 개입이 재범률을 유의미하게 감소시킬 수 있음을 입증했다(Hanson & Bussière, 1998). 하지만, 성범죄자를 대상으로 한 마음챙김 연구는 제한적이다(Simpson-Gledhill et al., 2018). 따라서 본 연구는 교정기관 내 성범죄자를 대상으로 한 MBCT 기반 통합 성범죄 프로그램이 재범 위험 요인 완화 및 재범 예방을 실증적으로 검증하는 것을 주요 목적으로 한다. 이 연구는 기존 치료 접근법의 한계를 보완하는 데 이바지할 수 있는 기초 자료를 제공할 것이다. 이를 통해 성범죄자 치료의 새로운 모델을 제시하고, 교정심리 분야에서 증거 기반 개입(evidence-based intervention)의 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

본 연구는 MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료가 실제로 재범 예방에 효과적인지 과학적으로 입증하고, 교정 현장에 적용할 새로운 치료 모델을 제시하고자 한다. 이러한 결과는 향후 증거 기반의 재범 방지 개입 전략을 수립하는 데 필요한 기초 자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

방 법

프로그램 개발 절차

본 연구의 프로그램은 교정시설에 수용된 성폭력 사범을 대상으로 하며, 계획개발(Planning-Development), 실행(Execution), 평가(Evaluation)의 순환적 과정을 통해 개발되었다. 먼저 MBCT 전문가이며 심리학 박사 1인과 교정시설 실무자로 구성된 프로그램 개발팀을 구성하였다. 문헌고찰 개발팀은 먼저 MBCT 및 성범죄자 심리치료와 관련된 선행연구들을 고찰하였다. 이 과정을 통해 중독의 일반적 특성과 성범죄의 특성, 예컨대 인지 왜곡, 충동성, 공감 부족 등을 탐색하였다. 또한, 기존 성범죄 심리치료 프로그램들에서 다루어진 관련 변인 예컨대 자기 통제, 스트레스 대처, 대인관계 기술 등을 탐색 및 수집하였다. 실제 대상자인 D 교도소 수용 성폭력 사범 대상의 요구를 파악하고, 프로그램 참여자 선정을 위해 먼저 설문지를 제작하였다. 설문지는 성범

표 1. 프로그램(주 3회: 일 2회기, 12일 진행, 총 60시간)

목표	회기	주제	활동내용
동기 강화	1	프로그램 규칙 및 소개	- 프로그램 소개하고 규칙 설명하기 - SOTEST, K-MAAS 사전 검사 실시
	2	집단원 자기소개	- 집단원 별칭 정하기 및 소개 - 비밀유지 서약하기
	3	행복한 삶	- 나의 삶 생각하기 - 인생 그래프 그리기
	4	행복한 미래	- 인생 그래프 발표 - 행복한 날과 불행한 날 생각하기
자기 조절	5	성에 대한 이해	- 나의 성인지 알아보기 - 성인지 감수성
	6	성 관련 의사 결정	- 나의 성에 대한 인식 전환 - 성적 자기 결정권
	7	왜곡된 성 의식 확인	- 책임 있는 성행동 - 건강한 성인식
	8	성적 신념	- 성 통념 확인 및 수정하기 - 성 평등 의식 알기
	9	감정에 대한 이해	- 다양한 상황에서 감정 - 공감 능력 향상하기
	10	감정조절능력	- 상황에서 감정 생각 행동 알아차리기 - 적응적인 행동하기
MBCT	11	자동조종 상태에서 깨어나기	- 자동조종 상태에서 벗어나기 - 마음챙김과 자동 모드 이해하기
	12	또 하나의 존재 방식	- 행위 양식과 존재 양식 이해 - 같은 경험을 매번 다르게 해석한다는 것을 알아차리기, 습관 내려놓기
	13	흩어진 마음 모으기	- 자동조종 상태에서 빠져나와 현재의 순간으로 재연결하기
	14	혐오 인식하기	- 혐오감을 줄이며 부정적인 생각 대하기 - 주의를 집중하기와 확장하기
	15	있는 그대로 수용하기	- 경험을 바꾸려 하거나 부정하지 않고, 단지 일어난 그대로 인정하는 연습하기

표 1. 프로그램(주 3회: 일 2회기, 12일 진행, 총 60시간) (계속)

목표	회기	주제	활동내용
MBCT	16	생각은 사실이 아니다.	- 생각은 '절대적인 진실'이 아니라, 일시적인 '마음의 작용'일 뿐임을 이해하기
	17	자신을 잘 돌보기	- 잘하는 활동, 재미있는 활동 - 활동 계획 세우기
	18	행복한 삶 계획 세우기	- 나의 삶 - 미래 계획 세우기
행동 계획	19	성범죄 특성	- 성폭력 범죄 유형 알아보기 - 성폭력, 성매매, 성희롱, 음란범죄
	20	성범죄 법령	- 성범죄 관련 법령 알아보기
	21	재발 방지	- 출소 후 예상되는 상황 알아차리기 - 위험 상황 파악하기
	22	재발 방지	- 출소 후 대처전략 수립하기 - 위험 상황 대처하기
	23	프로그램 소감 나누기	- 프로그램 소감 나누기 - 나의 미래 그리기
	24	사후 검사	- 사후 척도검사 - 목표점검 및 종결 소감 나누기

죄자의 재범 위험성 및 심리적 특성을 파악할 수 있는 기존 척도(SOTEST)를 활용하여 구성하였으며, 교정심리 전문가 1인의 자문을 받아 수정 · 보완하였다. 설문 조사를 통해 프로그램의 특정 수준 이상의 재범 위험이 있는 잠재적 대상자를 선별하여 면접을 시행하였다. 면접 결과, 참여자들은 주로 충동 조절의 어려움, 스트레스 상황에서의 부적절한 대처 방식, 왜곡된 인지 및 대인관계 문제를 호소하였다. 이러한 요구를 바탕으로, 본 프로그램은 (1) 스트레스 및 부정적 감정에 대한 마음챙김 기반 대처와 (2) 자동적 사고(인지 왜곡)의 자각 및 탈중심화를 핵심 내용으로 반영하였다.

프로그램의 구성

본 프로그램은 MBCT를 핵심 기법으로 활용하여 성폭력 사범의 심리적 재활 및 재범 방지를 목표로 하며, 총 24회기를 동기 강화, 자기 조절, MBCT, 행동 계획 및 종결의 4가지 주요 단계로 나누어 구성된다.

1단계는 프로그램의 초기 적응과 참여 동기 확립에 초점을 맞춘다. 프로그램의 규칙과 목표를 소개하고 설명하며, 심리치료 효과 측정을 위한 성폭력 사범 치료 효과 척도집(Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit: SOTEST), 한국판 마음챙김 주의 자각 척도(Korean version

of Mindful Attention Awareness Scale: K-MAAS)를 사전 검사를 시행한다. 집단원들은 별칭을 정하고 소개하며 비밀유지 서약을 통해 집단의 신뢰를 형성한다. 자신의 삶을 되돌아보고, 인생 그래프를 그리고 발표하며 행복한 날과 불행한 날을 생각하는 활동을 통해 삶의 의미를 탐색한다. 성 관련 인식 전환, 나의 성인지 감수성을 알아보고, 성적 자기 결정권에 대한 이해를 높여 성에 대한 인식을 전환한다. 궁극적으로 책임 있는 성행동과 건강한 성인식을 확립하는 것을 목표로 왜곡된 성 의식을 확인한다.

2단계에서는 성적인 신념과 감정 반응을 조절하는 능력을 향상하는 데 집중한다. 잘못된 성 통념을 확인하고 수정하며, 올바른 성 평등 의식을 학습한다. 다양한 상황에서 타인의 감정에 대한 이해와 공감 능력을 향상한다. 또한, 구체적인 상황에서 감정, 생각, 행동의 연결고리를 알아차리고, 이를 바탕으로 충동적인 반응 대신 적응적인 행동을 연습한다.

3단계는 프로그램의 핵심 단계로, 마음챙김 기법을 활용하여 자동적인 인지 패턴에서 벗어나고, 부정적인 생각과 감정을 수용하는 훈련을 한다. 자동조종 상태에서 벗어나기 훈련을 통해 마음챙김과 자동모드를 이해한다. 행위 양식과 존재 양식을 이해하고, 경험을 매번 다르게 해석할 수 있음을 알아차려 습관을 내려놓는 훈련을 한다. 혐오감을 줄이며 부정적인 생각을 대하는 훈련을 통해 주의를 집중하고 확장하는 방법을 배운다. 경험을 바꾸려 하거나 부정하지 않고, 단지 일어난 그대로 인정하는 연습을 한다. 가장 중요한 인지적 전환으로 '생각은 사실이 아니다'라는 원리에 초점을 두어, 생각을 정신적 사건으로 여기고 재발 위험에 대비한 조기경보 시스템을 구축한다. 자신이 잘하거나 재미있어하는 활동을 통해 자신을 잘 돌보기 위한 활동 계획을 세우며, 미래의 행복을 위한 삶의 계획을 수립한다.

4단계는 재범 방지를 위한 구체적인 전략을 수립하고, 프로그램을 평가하며 종결한다. 성폭력 범죄 유형(성폭력, 성매매, 성희롱, 음란범죄)을 구체적으로 알아보고, 관련 성범죄 법령에 대해 학습한다. 출소 후 예상되는 위험 상황을 알아차리고 파악하여, 구체적인 대처 전략을 수립하고 위험 상황에 대처하는 방법을 연습한다. 프로그램 참여 소감을 나누고 나의 미래를 그리는 활동을 통해 성장의 경험을 통합한다. 마지막으로 사후 척도검사를 하고, 목표점검 및 종결 소감을 나누며 프로그램을 마무리한다.

연구 대상 및 절차

본 연구의 참여자 모집은 법원으로부터 성폭력 치료 프로그램 이수명령을 받고 교정시설에 수용 중인 성폭력 사범을 대상으로 이루어졌다. 이들 중 과거 관련 심리치료 경험이 없고, 신체적·정신적 장애가 없으며, 형기 종료일이 6개월 이내로 남은 수용자를 연구 참여 적격자로 우선 고려하였다. 연구진은 이 적격 대상자들에게 개별 상담을 통해 연구의 구체적인 목적과 내용, 교정기관 내 집단 심리치료 교육실이라는 진행 장소, 그리고 참여 시 예상되는 어려움 등을 상세히 설명하였다. 이 과정에서 연구 참여는 전적으로 자발적인 동의에 기반하며, 참여를 거부하더라도 어떠한 불이익도 받지 않음을 구두 안내 및 서면 동의서를 통해 명확히 알렸다. 이러한 절차를 통해 자발적 참여에 동의한 24명이 최종 연구

대상자로 선발되었다. 본 연구는 비동등성 통제집단 설계를 따랐으며, 참여자들은 형기 종료일의 근접성을 기준으로 두 집단에 배정되었다. 형기 종료가 임박한 실험집단에 배정되었고, 나머지 무처치 통제집단으로 분류되었다. 실험집단은 사전 검사 실시 후 준비된 프로그램을 진행하고 사후검사를 받았으며, 통제집단은 별도의 개입 없이 같은 시점에 사전·사후 검사만 받았다. 단, 연구의 윤리성을 확보하기 위해 모든 절차가 종료된 후 통제집단 참여자들에게도 실험집단과 같은 기본과정 프로그램을 제공하였다. 본 프로그램의 진행은 교정시설 심리치료팀 소속으로 관련 자격을 보유한 심리학 전공자와 심리학 박사 학위를 소지한 외부 전문가 1인이 공동으로 담당하였다.

측정 도구

성폭력 사범 치료 효과 척도집(Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit: SOTEST)

교정시설 내 성폭력 사범 심리치료 프로그램의 효과성 검증을 위해 2021년 법무부 교정본부의 연구용역으로 SOTEST가 개발되었다. 이 척도는 인지태도, 자기관리, 대인관계, 성적 관심, 치료적 요인의 5개 하위 요인을 갖는다. 측정 도구는 수형자가 직접 응답하는 자기 보고형(SOTEST-S) 143문항과 치료자가 평가하는 치료자용(SOTEST-T) 선별검사 17문항 및 확장검사 74문항으로 구성된다. 본 연구는 프로그램의 효과성을 검증하기 위해 프로그램 시작 전(사전 검사)과 종료 시점(사후 검사)에 SOTEST-S를 실시하였으며, 각 문항 점수(진위형 0점 또는 1점)가 합산되어 결과가 산출되었다. 프로그램의 효과는 SOTEST-S의 하위 척도별 T 점수를 비교하여 분석하였다. 대부분의 하위 척도는 사후 검사 점수가 사전 검사에 비해 유의미하게 감소할수록 긍정적인 심리치료 효과가 있음을 의미한다. 단, 치료적 요인 하위 척도에 한해서는 사전 점수 대비 사후 점수의 유의한 상승은 긍정적인 치료 효과를 반영하는 것으로 해석한다. 본 연구에서 척도의 내적 합치도(Cronbach's α)는 표 3에 제시하였다.

한국판 마음챙김 주의 자각 척도(Korean version of Mindful Attention Awareness Scale: K-MAAS)

본 연구는 마음챙김을 측정하기 위해 K-MAAS (Korean version of Mindful Attention Awareness Scale)를 사용하였다. 이는 Brown과 Ryan(2003)이 개발한 MAAS를 권선중과 김교헌(2007)이 한국판으로 번안하고 타당화한 도구이다. K-MAAS는 총 15개 문항, 7점 Likert 척도(1점=전혀 그렇지 않다, 7점=항상 그렇다)로 구성된 단일 요인 척도이다. 모든 문항은 마음챙김의 부재를 묻는 부정 문항으로, 점수를 역환산하여 사용하였다. 따라서 총점이 높을수록 마음챙김 수준이 높음을 의미한다. 본 연구에서 척도의 내적 합치도(Cronbach's α)는 표 4에 제시하였다.

분석 방법

본 연구는 프로그램의 효과성을 검증하기 위해 SPSS 25.0 통계 프로그램을 사용하여 분석하였다. 먼저, 본 연구에서 사용한 측정도구의 신뢰도를 검증하기 위해 내적 합치도(Cronbach's α)를 산출하였다. 다음으로, 실험

집단과 통제집단 간 인구통계학적 특성의 동질성을 확인하기 위해 독립표본 t-검증(Independent samples t-test)을, 주요 변인의 사전 점수 동질성을 검증하기 위해 독립표본 t-검증을 하였다. 실험집단 하위 요인 간 대응표본 t-검정을 하였다. 마지막으로, 프로그램의 효과성, 즉 집단(실험, 통제)과 시기(사전, 사후) 간의 상호작용 효과를 검증하기 위해 반복측정 분산분석(Repeated measures ANOVA)을 수행하였다.

결 과

인구통계학적 특성

실험집단과 통제집단의 인구통계학적 특성이 동질하게 구성되었는지 확인하기 위해 독립표본 t-검증을 시행하였다. 그 결과, 대상자 모두 남성, 나이(t=-.13, p=.90), 학력(t=.24, p=.81), 범수(t=-.26, p=.80), 형량(t=-.60, p=.56)로 나타났다. 이는 두 집단의 (사전) 평균 점수 간에 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 이는 두 집단이 동질적임을 시사한다. 그 결과는 표 2에 제시하였다.

실험집단과 통제집단 간 사전동질성 검정

프로그램 시행 전 실험집단과 통제집단의 SOTEST와 K-MAAS의 동질성을 검정하기 위해 점수의 평균 차이를 독립표본 t - 검정을 시행하였다. 분석결과 SOTEST와 K-MAAS에서 실험집단과 통제집단 간의 모든 척도에서 통계적으로 유의하지 않았다. 이러한 결과는 두 집단이 동질적인 집단임을 확인시켜 주었다. 그 결과는 표 3과 표 4에 제시하였다.

표 2. 집단별 나이, 학력, 범수, 형량 차이 검정

변인	분류	실험집단	통제집단	t	p
나이		41.67(12.41)	42.33(12.92)	-.13	.90
학력	초등학교 졸업	1	2	.24	.81
	중학교 졸업	4	3		
	고등학교 졸업	6	6		
	대학교 졸업(2년제 이상)	1	1		
범수	초범	7	6	-.26	.80
	2회	3	4		
	3회 이상	2	2		
형량	1년 미만	8	5	-.60	.56
	1년 이상~ 2년 미만	1	3		
	2년 이상~ 3년 미만	1	2		
	3년 이상~4년 미만	1	1		
	4년 이상	1	1		

표 3. 실험집단과 통제집단 간 SOTEST 하위 요인 사전 점수 동질성 검사 결과(N=24)

변인	실험집단		통제집단		*t*	*p*	*Cronbach's α*
	M	*SD*	*M*	*SD*			
인지태도	63.15	11.49	63.80	12.78	-.13	.90	.73
자기관리	61.09	11.26	62.24	12.47	-.24	.81	.75
대인관계	56.55	10.20	59.15	10.07	.06	.95	.74
성적관심	71.79	22.44	73.03	20.34	-.14	.89	.73
치료적요인	49.07	10.78	47.70	11.08	.31	.76	.83

표 4. 실험집단과 통제집단 간 K-MAAS 사전 점수 동질성 검사 결과(N=24)

변인	실험집단		통제집단		*t*	*p*	*Cronbach's α*
	M	*SD*	*M*	*SD*			
마음챙김	45.00	3.36	44.75	3.39	.18	.86	.84

프로그램의 SOTEST 효과 검정 결과

프로그램의 효과성을 평가하기 위해 SOTEST의 T점수를 반복측정분산분석(repeated measures ANOVA) 하였다. 참가자 간 변인은(실험집단, 통제집단), 참가자 내 변인은 시기(사전, 사후)로 설정하였다. 그 결과는 표 5에 제시하였다.

분석결과, 첫째, 인지태도 요인에서 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=3.20$, $p=.09$]이며, 시기(B)의 주 효과[$F(1, 22)=19.64$, $p<.001$]가 통계적으로 유의하게 나타났다. 특히, 집단과 시기의 상호작용 효과(A×B) 역시 통계적으로 유의하게 나타나[$F(1, 22)=19.98$, $p<.001$], 시간에 따른 인지태도의 변화 양상이 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있음을 확인하였다. 둘째, 자기관리 요인에서도 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=1.41$, $p=.25$]이며, 시기(B)의 주 효과[$F(1, 22)=17.54$, $p<.001$]가 유의하게 나타났다. 또한, 집단과 시기의 상호작용 효과(A×B)가 통계적으로 유의하여[$F(1, 22)=16.61$, $p<.001$], 자기관리 점수의 변화가 집단에 따라 차이가 나타났음을 시사한다. 셋째, 대인관계 요인의 경우, 시기(B)에 따른 주 효과는 [$F(1, 22)=0.87$, $p=.36$], 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=0.00$, $p=.97$]와 집단 및 시기의 상호작용 효과(A×B)는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다[$F(1, 22)=0.07$, $p=.79$]. 이는 시간에 따른 대인관계 점수 변화가 두 집단 간에 유의한 차이가 없었음을 의미한다. 넷째, 성적 관심 요인에서는 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=0.68$, $p=.42$]이며, 시기(B)의 주 효과[$F(1, 22)=8.97$, $p<.05$]가 유의하였다. 집단과 시기의 상호작용 효과(A×B) 또한 유의하게 나타나[$F(1, 22)=7.32$, $p<.05$], 시간에 따른 변화 양상에 집단 간 차이가 있음을 보여주었다. 마지막으로, 치료적 요인에서도 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=1.85$, $p=.19$]이며, 시기(B)의 주 효과[$F(1, 22)=18.05$, $p<.001$]가 유의하게 나타났다. 집단과

표 5. SOTEST 실험집단과 통제집단 사전·사후 반복측정 분산분석(N=24)

종속변인	독립변인	*SS*	*df*	*MS*	*F*
인지태도	A	752.89	1.00	752.89	3.20
	B	623.39	1.00	623.39	19.64***
	A*B	633.93	1.00	633.93	19.98***
자기관리	A	397.38	1.00	397.38	1.41
	B	268.71	1.00	268.71	17.54***
	A*B	254.52	1.00	254.52	16.61***
대인관계	A	0.34	1.00	0.34	0.00
	B	0.60	1.00	0.60	0.87
	A*B	0.05	1.00	0.05	0.07
성적관심	A	512.87	1.00	512.87	0.68
	B	412.43	1.00	412.43	8.97*
	A*B	336.66	1.00	336.66	7.32*
치료적요인	A	325.52	1.00	325.52	1.85
	B	357.52	1.00	357.52	18.05***
	A*B	176.33	1.00	176.33	8.90*
오차			22		

주. A=집단, B=시기. * $p<.05$, *** $p<.001$

시기의 상호작용 효과(A×B) 역시 통계적으로 유의하여[$F(1, 22)=8.90$, $p<.05$], 치료적 요인의 변화가 집단별로 다르게 나타났음을 확인하였다. 요약하면, SOTEST의 5개 하위 요인 중 대인관계를 제외한 인지태도, 자기관리, 성적관심, 치료적요인 4개 요인에서 집단과 시기 간의 상호작용 효과가 통계적으로 유의하게 나타났다. 이는 해당 요인들에서 실험집단이 통제집단과 비교하여 사전·사후 시점 간에 유의한 변화 차이가 있음을 시사한다.

프로그램의 K-MAAS 효과 검증 결과

프로그램의 효과성을 평가하기 위해 K-MAAS에 대해 반복측정분산분석(repeated measures ANOVA)을 하였다. 참가자 간 변인은(실험집단, 통제집단), 참가자 내 변인은 시기(프로그램 사전, 프로그램 사후)로 설정하였다. 그 결과는 표 6에 제시하였다.

K-MAAS에서 집단(A)의 주 효과[$F(1, 22)=1.01$, $p=.33$]이며, 시기(B)의 주 효과[$F(1, 22)=14.85$, $p<.001$]가 유의하게 나타났다. 집단과 시기의 상호작용 효과(A×B) 역시 통계적으로 유의하여[$F(1, 22)=11.04$, $p<.001$], 마음챙김 점수의 변화가 집단별로 다르게 나타났음을 확인하였다. 요약하면, 시간의 흐름(사전·사후)에 따른 K-MAAS의 변화 양상이 유의한 변화

표 6. K-MAAS 실험집단과 통제집단 사전 · 사후 반복측정 분산분석(N=24)

종속변인	독립변인	*SS*	*df*	*MS*	*F*
마음챙김	A	20.02	1.00	20.02	1.01
	B	17.52	1.00	17.52	14.85***
	A*B	13.02	1.00	13.02	11.04***
오차			22		

주. A=집단, B=시기. *** $p<.001$

차이가 있음을 시사한다.

실험집단 사전 · 사후 차이 검증 결과

실험집단 대응표본 t-검정(Paired t-test) 결과, MBCT 프로그램 시행 전후에 따른 주요변인의 변화는 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 구체적으로 살펴보면, 인지태도는 사전(M=63.15, SD=11.49)에서 사후(M=48.67, SD=9.26)로 유의하게 감소하였으며, 그 차이는 매우 큰 효과 크기였다(t=4.46, p<.001, d=1.29). 또한 자기관리 역시 사전(M=61.09, SD=11.26)에서 사후(M=51.76, SD=12.73)로 유의하게 감소하였고, 효과 크기는 매우 큰 수준이었다(t=4.24, p<.001, d=1.22). 반면 대인관계는 사전(M=56.55, SD=10.20)과 사후(M=56.26, SD=10.38) 간 차이가 유의하지 않았으며, 효과 크기도 중간 수준이었다(t=1.55, p=.15, d=0.45). 성적 관심은 사전(M=71.79, SD=22.44)에서 사후(M=60.63, SD=17.78)로 유의하게 감소하였고, 큰 수준의 효과가 나타났다(t=2.89, p<.05, d=0.83). 치료적 요인은 사전(M=49.07, SD=10.78)에서 사후(M=58.36, SD=6.88)으로 유의하게 증가하였으며, 효과 크기는 매우 큰 수준이었다(t=-3.99, p<.001, d=1.15). 마지막으로 마음챙김 또한 사전(M= 45.00, SD=3.36)에서 사후(M=47.25, SD=2.80)로 유의하게 증가하였으며, 매우 큰 수준의 효과가 나타났다(t=3.89, p<.001, d=1.12). 그 결과는 표 7에 제시하였다.

표 7. 실험집단 사전 · 사후 차이검증 결과(N=12)

변인	사전 검사		사후 검사		*t*	*p*	*cohen d*
	M	*SD*	*M*	*SD*			
인지태도	63.15	11.49	48.67	9.26	4.46	< .001	1.29
자기관리	61.09	11.26	51.76	12.73	4.24	< .001	1.22
대인관계	56.55	10.20	56.26	10.38	1.55	.15	.45
성적관심	71.79	22.44	60.63	17.78	2.89	.01	.83
치료적요인	49.07	10.78	58.36	6.88	-3.99	< .001	1.15
마음챙김	45.00	3.36	47.25	2.80	-3.89	< .001	1.12

논 의

본 연구는 대구지방교정청 D 교도소에 수용 중인 성폭력 이수명령 대상자 24명을 12명의 실험집단과 12명의 무처치 통제집단으로 배정하여, 비동등성 사전·사후 통제집단 설계를 적용하였다. 연구의 목적은 실험집단에 처치한 MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료 프로그램의 효과성을 검증하는 것이었다. 프로그램 개입 전후로 SOTEST와 K-MAAS를 사용하여 두 집단의 변화를 비교 분석한 결과, 프로그램에 참여한 실험집단은 SOTEST의 하위요인 중 인지태도, 자기관리, 성적관심, 치료적 요인, 그리고 K-MAAS에서 통계적으로 유의한 긍정적 변화를 나타냈다. 반면, 무처치 통제집단에서는 사전 검사 점수와 사후 검사 점수 간 유의한 차이가 발견되지 않았다. 이러한 주요 연구 결과를 심층적으로 해석하고, 그 결과가 갖는 이론적 및 실천적 해석을 논의하고자 한다. 마지막으로, 본 연구가 지니는 한계점을 논의하고 이를 극복하기 위한 향후 연구의 필요성을 제안하고자 한다.

이러한 효과의 중심에는 마음챙김(Mindfulness)이라는 핵심 기제가 자리하고 있다. 인지행동치료(CBT)가 왜곡된 신념이나 자동적 사고의 내용을 수정하는 데 초점을 맞추는 것과 달리(Beck & Beck, 2011), 마음챙김은 자신의 내면에서 일어나는 생각과 감정, 신체 감각을 비판단적인 태도로 알아차리고 수용하는 과정 자체를 훈련한다(Kabat-Zinn, 2013). 성폭력 사범들의 범죄 행동은, 종종 왜곡된 성적 환상이나 충동적 분노와 같은 부정적인 내적 경험 때문에 자동으로 촉발되는 특성을 보인다(Marlatt & Donovan, 2003).

본 프로그램의 마음챙김 훈련은 참여자들이 이러한 내적 경험이 떠오르는 순간, 그것에 즉각적으로 반응하는 대신 한 걸음 물러서서 객관적으로 관찰할 수 있는 심리적 공간을 만들어주는 역할을 했을 것으로 해석된다(Segal et al., 2013). 즉, 충동 → 자동적 행동의 고리를 끊고, 그 사이에 알아차림과 수용이라는 완충 지대를 형성함으로써 자기 조절 능력을 근본적으로 향상하게 시킨 것이다. 실제로 실험집단은 K-MAAS 점수에서도 유의한 향상을 보였다. 이는 프로그램이 단순히 성범죄 관련 지식을 전달하는 것을 넘어, 참여자들의 내적 경험을 다루는 방식 자체를 변화시켰음을 보여주는 중요한 증거이다(Shapiro et al., 2006). 마음챙김 능력이 향상됨에 따라 참여자들은 자신의 위험 신호를 더 빨리 감지하고, 스트레스 상황에서 더 효과적으로 대처하며, 궁극적으로 재범으로 이어질 수 있는 위험 상황을 예방하는 능력을 갖추게 되었을 것이다. 이는 우울증 재발 방지를 위해 개발된 MBCT가 부정적 감정에 대한 탈중심화(decentering)를 통해 효과를 발휘하는 것과 유사한 기제이다(Segal, Williams, & Teasdale, 2018).

본 연구 결과에서 주목할 또 다른 지점은 프로그램의 효과가 SOTEST의 모든 하위 요인에서 같게 나타나지 않았다는 점이다. 구체적으로 인지태도, 자기관리, 성적관심, 치료적 요인에서는 유의한 긍정적 변화가 나타났으나, 대인관계 영역에서는 유의한 차이가 발견되지 않았다. 이러한 차별적 효과는 프로그램의 특성과 성범죄자의 복합적인 문제 영역을 이해하는 데 중요한 시사점을 제공한다.

첫째, 본 연구에서 개발한 MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료 프로그램은 자기관리와 성적관심 영역에서의 긍정적 변화는 MBCT의 핵심 원리가 가장 직접 작용한 결과로 볼 수 있다.

이 두 영역은 주로 개인의 내적 충동, 감정 조절, 왜곡된 인지 및 성적 환상과 관련이 깊다. 마음챙김 훈련은 자신의 신체 감각과 감정에 대한 민감성을 높여 분노나 성적 충동이 일어나는 초기 신호를 알아차리게 하고, 호흡 명상 등은 이러한 충동에 휩쓸리지 않고 다루는 힘을 길러준다. 이는 곧 자기관리 능력의 향상으로 이어진다. 또한, 왜곡된 성적 관심이나 판타지에 관해 판단하지 않고 관찰하는 훈련은 그것의 힘을 약화하고, 건강한 성적 가치관을 재정립하는 데 이바지했다는 점은 Garland 외(2017)의 연구와 일치한다.

둘째, SOTEST의 하위 요인에서 치료적 요인의 향상 또한 중요한 성과이다. 성폭력 사범들은 종종 자신의 문제를 합리화하거나 부인하며, 치료에 대한 저항이 높다. 비판단과 수용을 강조하는 마음챙김의 태도는 참여자들이 느끼는 자기 비난과 수치심을 감소시켜, 이들이 자신의 문제를 보다 안전한 환경에서 직면하고 탐색하도록 도왔을 것이다. 이러한 심리적 안전감은 치료적 동맹을 강화하고, 변화에 대한 내적 동기를 촉진하는 핵심적인 요소로 작용했을 가능성이 크다.

반면, '대인관계' 영역에서 유의한 변화가 없었던 점은 본 연구에서 사용된 프로그램의 한계를 명확히 보여준다. 마음챙김은 본질에서 개인의 내적 경험에 초점을 맞추는 내성적(introspective) 기술이다. 따라서 타인의 감정을 이해하고 공감하는 능력, 건강한 관계를 형성하고 유지하는 사회적 기술 등 상호작용적(interactive) 능력을 향상하게 시키는 데는 직접적인 효과가 제한적일 수 있다. 성폭력 범죄의 기저에 피해자의 고통에 대한 공감 능력 부재와 왜곡된 대인관계 방식이 존재한다는 점을 고려할 때(Laws & Ward, 2011), 이는 매우 중요한 지점이다. 본 프로그램이 자기 성찰에 집중한 나머지, 역할극, 의사소통 훈련, 공감 훈련과 같이 대인관계 기술을 직접 다루는 구조화된 요소가 부족했을 수 있다.

본 연구는 여러 의의에도 불구하고 몇 가지 한계를 지니고 있으며, 이는 후속 연구를 통해 보완될 필요가 있다.

첫째, 본 연구는 대구 지역의 단일 교정기관에서 24명(실험집단 12명)이라는 소규모 표본을 대상으로 이루어졌다. 이는 연구 결과의 통계적 검증력을 약화하고, 연구 결과를 전국의 모든 성폭력 사범 수용자에게 일반화하는 데 심각한 제약을 가한다. 참여자들의 범죄 유형, 나이, 교육 수준 등 인구통계학적 특성의 다양성을 충분히 확보하지 못했을 가능성도 존재한다.

둘째, 연구 설계가 단기적인 사전 · 사후 검사에 의존하고 있어, 프로그램의 효과가 장기적으로 지속되는지에 대해서는 답을 주지 못한다. 프로그램 종료 직후의 긍정적인 변화가 시간이 지남에 따라 약화할 수도 있으며, 가장 중요한 지표인 출소 후 실제 재범률 감소로 이어지는지는 확인할 수 없었다.

셋째, 본 연구는 자발적 참여자를 대상으로 진행되었으므로, 일반 수형자와 비교하여 치료 및 변화에 대한 동기가 상대적으로 높은 집단이 선정되었을 가능성이 있다. 이에 자신의 변화를 과장하여 보고했을 가능성이 있다.

결론적으로, 본 연구는 MBCT 기반 통합 성범죄 심리치료 프로그램이 교정시설 내 성폭력 사범의 재범 위험 요인 감소에 효과적인 개입 방안이 될 수 있다는 중요한 경험적 근거를 제시하였다. 비록 표본의 크기와 장기적 효과 검증의 부재라는 한계를 지니고 있지만, 후속 연구를 통해 이러한 제한점들을 극복하

고 프로그램을 더욱 정교하게 발전시켜 나간다면, 이는 우리 사회의 안전을 증진하고 성공적인 사회 복귀를 돕는 중요한 교정 정책의 초석이 될 수 있을 것이다.

참고문헌

권선중, 김교헌 (2007). 한국판 마음챙김 주의 알아차림 척도(K-MAAS)의 타당화 연구. 한국심리학회지: 건강, 12(1), 269-287.

김민영, 이태헌, 윤정숙 (2020). 교정시설 내 성범죄자 심리치료 프로그램 효과성 평가 연구. (연구총서 20-AB-02). 한국형사・법무정책연구원.

김정내, 이종연 (2017). 성폭력가해자를 대상으로 한 개입 프로그램의 국내 연구동향. 교정복지연구, 48, 127-147.

문선희, 홍창희 (2012). 마음챙김이 충동성에 미치는 영향: 정서조절곤란과 탈중심화의 매개효과. 한국심리학회지: 건강, 17(1), 173-187.

박지선, 이수정 (2018). 성범죄자 치료프로그램의 효과성에 대한 메타분석. 한국심리학회지: 사회 및 성격, 32(1), 63-83.

법무부 (2022). 성폭력 사범 치료 효과 척도집 (Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit: SOTEST). [미출판 척도집].

법무부 교정본부 (2024). 2024 교정통계연보.

서수균, 김교헌 (2011). 수치심과 분노의 관계에서 자기자비와 공감의 역할. 한국심리학회지: 건강, 16(4), 849-864.

이동훈, 최윤희 (2015). 제3세대 인지행동치료의 통합적 고찰: ACT, DBT, MBCT, SFT를 중심으로. 한국심리학회지: 임상, 34(4), 865-894.

전미애, 김정모 (2011). 마음챙김에 기초한 인지치료(MBCT) 프로그램이 교도소 수형자의 정신건강과 분노행동에 미치는 효과. 교정연구, 53, 145-168.

Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice, 10*(2), 125-143.

Beck, J. S., & Beck, A. T. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.

Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y. Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(50), 20254-20259.

Brouillette-Alarie, S., Côté, G., & Proulx, J. (2016). The Effect of a Mindfulness-Based Program on Sexual Fantasies and Impulsivity in Sexual Offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 28*(8), 731-753.

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 84*(4), 822-848.

Dimeff, L. A., & Linehan, M. M. (2008). Dialectical behavior therapy for substance abusers. *Addiction Science & Clinical Practice, 4*(2), 39-47.

Garland, E. L., Hanley, A. W., Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2017). Testing the mindfulness-to-meaning theory: Evidence for mediators of decentering and positive

reappraisal. *Psychosomatic Medicine, 79*(3), 308-316.

Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66*(2), 348-362.

Kabat-Zinn, J. (2013). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness* (Revised ed.). Bantam Books.

Kingston, D. A., Olver, M. E., & Gobeil, A. (2018). Mindfulness-based interventions and risk factors for sexual recidivism: A systematic review and preliminary meta-analysis. *The Journal of Sex Research, 55*(4-5), 456-470.

Laws, D. R., & Ward, T. (Eds.). (2011). *Desistance from sex offending: Alternatives to relapse prevention*. Guilford Press.

Ma, S. H., & Teasdale, J. D. (2004). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: Replication and exploration of differential relapse prevention effects. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72*(1), 31-40.

Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O'Brien, M. D. (2011). Treating sexual offenders: An integrated approach. Routledge.

Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (Eds.). (2003). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors* (2nd ed.). Guilford Press.

Segal, Z. V., Kennedy, S., Gemar, M., Hood, K., Pedersen, R., & Buis, T. (2006). Cognitive reactivity to sad mood provocation and the prediction of depressive relapse. Archives of General Psychiatry, 63(7), 749-755.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2013). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression*(2nd ed.). Guilford Press.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2018). *Mindfulness-based cognitive therapy: Embodied new approaches*. Guilford Press.

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. *Journal of Clinical Psychology, 62*(3), 373-386.

Simpson-Gledhill, A., Kverme, B., & Beech, A. R. (2018). Mindfulness-based interventions for sexual offenders: A systematic review of the literature. *Aggression and Violent Behavior, 43*, 78-91.

Teasdale, J. D., Moore, R. G., Hayhurst, H., Pope, M., Williams, S., & Segal, Z. V. (2002). Metacognitive awareness and prevention of relapse in depression: Empirical evidence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70*(2), 275-287.

Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. *Aggression and Violent Behavior, 11*(1), 44-63.

원고접수일 : 2025. 11. 20.
게재확정일 : 2025. 12. 26.

한국심리학회지: 중독
Korean Journal of Addiction Psychology
2025, Vol. 10, No. 2, 1-16

The Effect of an MBCT-Based Integrated Psychological Treatment Program for Sex Offenders

Gyu-Yeol Yang
Psychological Treatment Team
Daegu Prison Center

Hyun-Wook Shin
Eum Psychological Counseling

This study examined the effectiveness of an MBCT-based integrated psychological treatment program for individuals convicted of sexual violence incarcerated at D Prison under the Daegu Regional Correctional Office. A total of 24 offenders subject to a court-mandated treatment order participated in the study and were assigned to either an experimental group (n = 12), which received the intervention, or a control group (n = 12), which did not receive any treatment. To evaluate program outcomes, the Sex Offender Treatment Evaluation Scale (SOTEST) and the Korean version of the Mindful Attention Awareness Scale (K-MAAS) were administered before and after the intervention. The results indicated that the experimental group showed statistically significant reductions in cognitive attitudes, self-management, and sexual interest factors of the SOTEST, along with a significant improvement in therapeutic factors. However, no significant change was observed in the interpersonal relationship factor. In contrast, the control group showed no statistically significant changes across any SOTEST factors during the same period. Additionally, only the experimental group demonstrated a significant increase in K-MAAS scores, indicating an enhancement in mindfulness levels following program participation. These findings suggest that an MBCT-based integrated psychological treatment program may contribute to improving psychological variables associated with recidivism risk among sexual offenders in correctional settings. Nevertheless, the study is limited by its small sample size and confinement to a single correctional facility. Future research should replicate these findings using larger samples and multiple correctional institutions to enhance the generalizability of the results.

Key words : Sexual offending, Sexual offenders, MBCT, Treatment effectiveness, Correctional inmates